

2026년 6차 약제급여평가위원회 사전 검토 보고

직전 차수 통과 약제 회고 · 6/4 회의 쟁점 deep dive

회의	약제급여평가위원회 2026년 제6차
일자	2026-06-04 (목)
직전 차수	2026-05-07 제5차 약평위 (HIRA 공식 brdBltno=11793)
위원회	10기 약평위 (2025-09 출범, 위원 74명 중 30명 유임·44명 신규) — 위원장 정현철 (심평원 상근위원, 연세암센터 출신 종양내과 전문의·한국임상암학회 이사장)
정부 인사	2026-05-18 강준혁 신임 보험약제과장 부임 — 본 회의가 첫 정기 의결
정책 환경	2026-06-01 약가 유연계약제 첫 시행 — 본 회의가 시행 후 첫 약평위

들어가며

본 보고서는 약제급여평가위원회 6차 회의를 앞두고, 직전 5차 약평위 통과 약제 회고와 6/4 회의의 안건 후보별 쟁점·결정 변수를 정리한다. 출처는 심평원(HIRA) 공식 보도자료를 1차 권위로 하고, 매체 보도는 통과·미통과 사유와 시장 맥락 해석에 활용한다.

본 회의는 **10기 약평위의 종양내과 전문 위원장 체제 + 신임 보험약제과장 첫 정기 의결 + 약가 유연계약제 시행 직후 첫 약평위**가 동시에 겹치는 분기점이다. 본 보고서가 다루는 쟁점들은 본 차수의 직접 결과뿐 아니라 향후 12개월 한국 신약 등재 환경의 baseline 형성에 영향을 미친다.

1. 직전 차수 회고 — 5/7 5차 약평위 통과 약제 Deep Dive

심평원 공식 보도자료(brdBltno=11793)는 본 차수에서 결정신청 5종, 신약 승인 2종, 위험분담 확대 1종, 재심의 1종을 명시했다. 항암제·중증질환 신약 4종을 본 회의 안건 후보와 직접 연결되는 관점에서 본다.

1-1. 예스카타주 (axicabtagene ciloleucel) — 길리어드코리아 · CAR-T · 림프종

통과 쟁점: 글로벌 두 번째 CD19 CAR-T로, 한국 시장에는 노바티스 킴리아가 이미 reference price를 설정해 둔 상태(환자부담 최대 598만원 수준, 산정특례)였다. 핵심 쟁점은 (1) 2차(1차 화학면역요법 후 12개월 내 재발·불응 DLBCL) 대 3차(2차 이상 전신치료 후 재발·불응)의 적응증 분리, (2) CAR-T 1회 투여 글로벌 가격이 4~5억원대인 점에서 발생하는 재정 부담, (3) 신규 CAR-T 약가의 킴리아 reference 차별화 폭이었다.

통과 조건: "평가금액 이하 수용 시" 조건부 통과. 적응증은 **3차로 제한** — 2차 적응증은 본 차수 약평위 통과 실패. 후속 단계는 NHIS 약가협상 → 건정심 → 고시.

통과 히스토리: 2021-03 식약처 허가 → 2024 1차 적응증(DLBCL 2차) 추가 허가 → 2026-01 1차 암질심 통과(3차만) → 2026-05-07 5차 약평위 통과(3차만). 한국 reimbursement journey 약 5년. 글로벌 reference: FDA 2017, EMA 2018, NICE 2019.

시장 함의: 후속 NHIS 협상이 향후 림카토(큐로셀 국산 CAR-T) 약가 협상의 reference로 작용할 가능성. 글로벌 CAR-T 가격 ceiling 형성의 분기점.

1-2. 레테브모캡술 (셀퍼카티닙) — 한국릴리 · RET 표적 · 폐암·갑상선암

통과 쟁점: 국내 최초 RET 표적 항암제로 단독품목 성격이 강해 ICER 임계값 적용 여유. 다만 (1) RET fusion+ NSCLC와 RET-mutant MTC, RET fusion+ 갑상선암 3개 적응증 동시 평가의 복잡성, (2) 비교약제 부재로 인한 LIBRETTO-001 single-arm trial 평가의 불확실성이 핵심이었다.

통과 조건: 3개 적응증 모두 급여 적정성 인정(조건 단서 없이). 적응증: ① 국소진행성·전이성 RET fusion+ NSCLC, ② 진행성·전이성 RET-mutant MTC, ③ 소라페닙·렌바티닙 치료 경험 RET fusion+ 갑상선암. 단독품목 RSA 적용 예상.

통과 히스토리: 2022 식약처 허가(국내 첫 RET 타깃 신약) → 2022~2025 암질심 다회 도전 끝 통과 → 2026-05-07 5차 약평위 통과. 글로벌: FDA 2020-05 가속승인 → 2022 정식승인.

시장 함의: precision oncology의 small subpopulation drug이 한국에서 단독품목 우대 경로로 안착한 사례.

1-3. 티센트릭주 (아테졸리주맙) — 한국로슈 · NSCLC adjuvant 확대 · RSA ★ MSD 직접 영향

통과 쟁점: 신약 등재가 아닌 기존 RSA 약제의 사용범위 확대 트랙. 핵심 이슈는 (1) **수술 후 보조요법(adjunct) 영역의 면역항암제 확대** — IMpower010 DFS 데이터는 PD-L1 ≥50% subgroup에서 가장 강했으나 OS 데이터 미성숙, (2) 기존 진행성·전이성 NSCLC 1차 RSA와 별개의 early-stage 환자 풀 추가로 BIA 큰 폭 증가, (3) 키트루다 adjuvant(KEYNOTE-091)와의 class effect였다.

통과 조건: RSA 확대 적정성 인정. 확대 적응증은 "PD-L1 발현 비율 종양세포 50% 이상, 병기 II~IIIA 초기 NSCLC, 절제 및 백금기반 화학요법 후 수술 후 보조요법" — PD-L1 50%+ subpopulation 한정으로 BIA 통제. 기존 진행성 NSCLC 1차 (2021 급여) 적응증은 유지된 상태에서 adjuvant 영역만 추가.

통과 히스토리: 2017 국내 허가 → 2021 NSCLC 1차 단독요법 급여 → 2022 보조요법 식약처 적응증 추가 → 2026-05-07 5차 약평위 RSA 확대 통과.

시장 함의 (MSD 자산 직접 영향): 면역항암제 adjuvant 시장의 한국 진입 본격화이며, **본 PD-L1 50%+ subpopulation 한정 RSA logic은 향후 한국MSD 키트루다 KEYNOTE-091 adjuvant 등재 협상의 직접 reference**가 된다. PD-L1 cutoff 적용·BIA 통제 방식·기존 RSA 위에 추가 layer 형식 — 모든 logic이 키트루다 후속 협상에 그대로 적용될 가능성.

1-4. 리브리반트주 (아미반타맙) — 한국얀센 · EGFR 변이 NSCLC · 재심의

통과 쟁점 (가장 첨예): (1) 이상반응 부담 — 약평위가 "최근 이상반응이 중요 판단요소"라 명시(피부독성·infusion reaction), (2) 재정 부담 — 연간 약값 약 1.5억원, 렉라자 병용 시 추가 가중, (3) 병용요법 약가 산정 logic 불명확 — 렉라자(국산)와의 cost-sharing 협상 구조 미정립, (4) 환자단체 청원과 국회 압력 — 미국·EMA·PMDA 1차 PAPILLON 기반 승인 대 한국 미설정의 형평성 논란.

통과 조건: 본 차수에서 **재심의 결정** (미통과·미부결 중간 status). 진입한 적응증은 EGFR 엑손20 삽입 변이 국소진행성·전이성 NSCLC 단독요법.

통과 히스토리 (한국 reimbursement에서 가장 오래된 trajectory): - 2021 국내 식약처 허가 (엑손20 단독) - 2022~2025 암질심 도전 4회 이상 미설정 (단독 + 렉라자 병용 + carboplatin·pemetrexed 병용 묶음) - 2025년 7차 암질심: 엑손20 단독요법만 급여기준 설정 성공 - 2026-05-07 5차 약평위: 엑손20 단독 첫 약평위 진입 → 재심의

총 한국 등재 journey 약 5년, 암질심·약평위 합산 도전 6회 이상.

시장 합의: 단독요법조차 약평위에서 재심의 받은 사실은 1.5억/년 약가가 평가금액과 mismatch 상태임을 시사. 한국 면역항암제·표적치료제 약가 ceiling이 실질적으로 작동함을 보여주는 사례.

2. 6/4 6차 약평위 — 안건 후보별 쟁점 (본 보고서 핵심)

본 차수 직접 안건은 심평원 공식 사전 공개되지 않으나 매체 D-2 시그널과 transition timing으로 다음 4종이 안건 후보로 분류된다. 각 약제에서 본 차수가 어떤 쟁점을 다룰지를 시니어 리더십 관점에서 정리한다.

2-1. 테빔브라(티슬렐리주맙) — 비원메디슨코리아 PD-1 면역항암제 ★ NEW · 본 차수 최대 쟁점

진입 가능성

D-2 시점 매체 신호(medicaltimes·dailypharm 복수 출처)가 6/4 상정 예상을 보도. 비원메디슨 한국법인은 2025년 6월 식약처 적응증 추가 승인 시점에 "한국 출시 면역항암제 중 가장 빠른 속도로 급여권 진입 추진"을 공식 언명. 2025년 마지막 암질심에서 식도암·위암·NSCLC 5개 적응증 통과 후 약평위 진입 단계.

본 차수 핵심 쟁점 4가지

쟁점 ①: 키트루다 reference price 차별화 폭 키트루다가 동일 5개 적응증 영역에서 이미 등재된 상태에서 테빔브라가 어느 폭으로 저가 포지셔닝할지가 결정변수. 매체는 키트루다 대비 저가 포지셔닝을 강조 — 한국 면역항암제 시장의 가격 baseline 변화 시그널.

쟁점 ②: 식도암 1차 PD-L1 무관(All-comer) 라벨의 한국 reimbursement 수용 여부 글로벌 라벨은 PD-L1 발현 무관 전체 인구이나 키트루다 식도암은 PD-L1 cutoff 적용. 한국 약평위가 글로벌 라벨 그대로 수용할지 또는 PD-L1 cutoff 적용할지가 향후 면역항암제 전 인구 적응증 평가의 reference가 된다.

쟁점 ③: 약가 유연계약제 첫 적용 가능성 ★ 6/1 시행 직후 첫 약평위라는 점에서 본 차수가 신약 등재 결정 시 유연계약 옵션 부착 가능성의 첫 등장 시점. 통과 시 RSA + 사용량-약가 연동 + 유연계약 옵션 다중 부착 가능성이 매체에서 매우 강하게 제기된다.

쟁점 ④: NCCN 가이드라인 키트루다 동등 권고의 협상 지렛대 활용 NCCN이 테빔브라를 키트루다와 동등 권고 등재. 비원메디슨이 이 권고를 약가 협상 지렛대로 활용해 한국 시장 진입을 가속할 가능성이 의협신문·매체에서 시사.

결정 변수 정리

본 차수 결정은 다음 두 axis로 본다 — (a) 통과/조건부/재심의/미통과, (b) 어떤 RSA·유연계약 구조 부착. 통과 시 키트루다 가격 압박 시그널, 조건부 시 가격 양보 전제, 재심의 시 다음 차수 보완 자료, 미통과 시 보완 후 재신청 4가지 시나리오 모두 한국 면역항암제 가격 환경에 시그널을 남긴다.

2-2. 리브리반트주 (아미반타맙) — 한국얀센 EGFR+ NSCLC

진입 가능성

5/7 5차 재심의 후 6/4 재상정 후보. 더바이오 6월 보도가 단독요법 4번째 시도 청신호 분석을 우세하게 다룬다. 약평위 재심의 → 1차수 후 재진입 패턴 (한국 약평위 통상 turnaround 1~2개월).

본 차수 핵심 쟁점 3가지

쟁점 ①: 단독요법 트랙 vs 병용요법 트랙 분리 처리 5차에서 엑손20 단독요법만 재심의 진입했고 렉라자·화학병용 등 다른 적응증은 별도 트랙에서 계속 미통과 상태. 본 차수가 단독요법만 처리할지 병용까지 통합 처리할지가 한국얀센 협상 전략에 영향. 매체는 단독요법 우선 통과 시나리오 우세.

쟁점 ②: 5차 재심의 사유 보완 여부 — 이상반응·약가 평가 5차 약평위가 "이상반응이 중요 판단요소"라 명시한 만큼 본 차수에서 한국얀센의 이상반응 관리 프로그램·약가 양보 자료가 통과 여부를 가른다. 1.5억/년 약가 수준이 평가금액과 mismatch 상태 — 가격 양보 폭이 핵심.

쟁점 ③: 4년+ trajectory의 마감 시점 2021 식약처 허가 → 4년+ 도전 history가 본 차수에서 단독요법만이라도 마감할 수 있을지가 한국 reimbursement에서 가장 오래 등재 trajectory를 가진 약물의 결산 시점이다.

2-3. 카보메틱스 (카보잔티닙) — 입센·HK이노엔 신장세포암

진입 가능성

매체 보도상 신세포암 투명세포암 1차 급여확대가 "평가금액 이하 수용 조건"으로 약평위 통과·좌초 반복. 1차 암질심 통과 후 약 4.5개월 transition 경과 — 본 차수 재진입 가능성 medium.

본 차수 핵심 쟁점 2가지

쟁점 ①: 가격 합의 도달 여부 조건부 통과 패턴이 반복되는 약제로 회사 측 가격 양보 폭이 결정변수. 본 차수 통과 시 "평가금액 이하 수용" 조건 다시 부착 가능성.

쟁점 ②: 적응증 인구 범위 글로벌은 1차 신장세포암 단독 적응증이나 한국에서 전체 인구 확대 vs 제한 인구가 BIA 통제와 직결.

2-4. 사이람자 (라무시루맙) — 한국릴리 위암

본 차수 직접 진입 시사 매체 보도 검색되지 않음. **진입 가능성 낮음.** 2018-05 위암 2차 단독·파클리탁셀 병용 급여 적용 중이며 추가 적응증 확대 트랙 시그널 부재.

2-5. 정기 운영 안건 가능성

10기 약평위 + 신임 보험약제과장 체제의 첫 정기 회의로서 신약 심의 외 약가재평가·기등재 인하·사용량·약가 연동 협상 결과 검토 등 정기 운영 안건 가능성. 운영 톤·의결 패턴 baseline이 본 회의에서 형성된다.

3. 본 회의 정책 환경 — 결정에 영향을 미칠 변수

3-1. 약가 유연계약제 6/1 첫 시행 ☆ 본 회의가 시행 후 첫 약평위

정부 약가 유연계약제(이중약가제)가 2026-06-01부터 첫 적용 개시됐다. RSA 적용 약제는 별도 상한금액 협상 대상에서 제외되며, **엑스탄디(엔잘루타미드·아스텔라스)**가 RSA → **약가 유연계약 전환 첫 케이스**다. 정부는 RSA 추가 확대보다 이중약가제 우회 정책 방향을 명시했다. 본 6/4 약평위는 시행 후 첫 약평위로, 신약 등재 결정 시 유연계약 옵션 부착 가능성의 첫 등장 시점이 된다.

3-2. 면역항암제 선별집중심사 — 운영 5개월차 시점

심평원이 2026년부터 면역체크포인트억제제를 선별집중심사 신규 항목으로 지정(키트루다·옵디보·임핀지 공통 적용). 키트루다 12개 요법 급여 확대 후 운영 시작. 본 회의가 시행 약 5개월차 시점으로 운영 중간 점검·비공식 검토 가능성. 테빔브라 통과 결정 시 본 정책 운영의 첫 대형 case가 된다.

3-3. 10기 약평위 위원장 정현철 체제 — 항암제 심사 깊이 ↑ 예상

10기 약평위 위원장이 심평원 상근위원이자 연세암센터 출신 종양내과 전문의·한국임상암학회 이사장인 정현철 박사로 결정. 위원 74명 중 신규 44명(59.5%). 항암제 임상 권위자의 약평위 통솔로 항암제 안건(테빔브라·리브리반트 등) 심사 깊이 강화 예상. 본 회의가 정 위원장 체제의 첫 정기 항암제 다수 안건 회차일 가능성.

3-4. 강준혁 신임 보험약제과장 정책 톤 첫 신호

2026-05-18 부임 후 본 회의가 첫 정기 의결. 의결 패턴·조건부 비중·RSA 활용 폭이 향후 12개월 정책 톤 baseline.

3-5. RSA 확대 추세 — 항암 외 영역으로

블린사이토(4차 RSA 확대) 외에도 파센라(중증 호산구성 천식) 약평위 통과 시 RSA 적용 등 항암제 외 만성·중증질환 영역으로 RSA 확장. 한국 reimbursement의 RSA 활용 폭이 구조적으로 넓어지는 trend로, 본 회의에서 신약 등재 시 RSA 부착 형식이 점점 표준화된다.

4. MSD 자산 직접 영향 — 시니어 모니터링 우선순위

본 회의 안건과 직전 5차 통과 약제 환경이 한국MSD 키트루다·웰리렉에 미치는 직접 영향은 다음 4건이 핵심이다.

4-1. 테빔브라 6/4 통과 가능성 — 키트루다 가격 압박 baseline 변화

NCCN 동등 권고 + 키트루다 대비 저가 포지셔닝 + 약가 유연계약 다중 부착 가능성. 통과 시 한국 면역항암제 시장의 가격 압박 baseline 변화 시그널 — 키트루다 후속 적응증 신청 협상 환경 첫 영향. 6/5 결과 발표 시 한국MSD가 후속 적응증 신청 timing·가격 카드 재점검 필요.

4-2. 티센트릭 NSCLC adjuvant 확대 logic → 키트루다 KEYNOTE-091 직접 reference

5차 통과 logic — PD-L1 50%+ subpopulation 한정 + 기존 RSA 위에 추가 layer + BIA 통제 — 이 그대로 한국MSD 키트루다 KEYNOTE-091 adjuvant 등재 협상 시 직접 적용된다. 사전 임상 패키지·BIA 시뮬레이션·RSA layer 설계 점검 필요.

4-3. 파드셉+키트루다 통합 협상 (4차 통과 후속) — 한국MSD 첫 직접 협상 참여

4차 약평위 통과 후 NHIS 협상 단계 진입. 한국MSD가 요로상피암 1차 협상에 직접 참여하는 첫 케이스로, 키트루다 약가 인하 압력 대 cost-sharing 협상 결과가 키트루다 다적응증 약가 사후관리 전략의 시험대다. NHIS 협상 결과 timeline 7~9월 예상.

4-4. 면역항암제 선별집중심사 운영 중간 검토 영향

시행 5개월차 시점으로 첫 운영 결과 비공식 검토 가능성. 키트루다·옵디보·임핀지 공통 적용이므로 후속 적응증 확대 협상 시 사용량 데이터 활용 영향. 9월 이후 첫 공식 검토 결과 시점에 본 회의에서 형성된 운영 톤이 baseline으로 작동.